

Fecha Última Actualización: 02-03-2023 2:21:37

Página 1 de 3

Información Paciente

Nombre : Florinda Laura Solano Machuca

Edad : 80a 1m 4d

Dirección : Avda C Henríquez 2525

Rut : 5.114.198-9

Fecha Nacto: 26/01/1943

Comuna : Puente Alto

N° Archivo : A027896

Sexo : Femenino

Teléfono : 9 5899 4229

N° Epicrisis

343522

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Recuperación (Tránsito Pabellón)

Fecha Ingreso : 15/12/2022 15:44

Días Estadía : 77

Unidad de Egreso : Utim

Fecha Egreso : 02/03/2023 01:26

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Accidente Vascular Isquémico

Comorbilidades

Hta; Dm2nir; Fa No Valvular En Taco;

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

- FI SUHSR: 15/12/2022
- FI UPC: 16/12/2022
- FI SALA: 27/01/23
- FI UTIM 5° 08/02/23
- FI PAM 18/02/23
- CONTACTO: 958994229 Marcela Marquez Hija

Anamnesis remota

Atcd Mórbidos: HTA, DM2NIR, FA no valvular en TACO

Fármacos: Digoxina, AAS, Atorvastatina, Espironolactona, Carvedilol y TACO

Atcd Quirúrgicos: (-)

Alergias: (-)

Hábitos: TBQ/OH/DRG (-)

Inmunizaciones: Covid 4 dosis, Influenza 2022

MC ACV

Anamnesis próxima: Paciente con hospitalización prolongada. Se realiza resumen operativo de hospitalización

Con atcd descritos, ingresa por ACV isquémico en relación a oclusión de ACI extracraneal en su origen con extensión a T. carotídea y M1 ipsilateral, se realizó trombectomía mecánica 15-12. Previo a procedimiento presentó episodio de macroaspiración presenciada requiriendo inicio de VMi. Se trasladó a UPC y posteriormente a sala básica y UTIM para continuar terapia

EVOLUCIÓN DURANTE HOSPITALIZACIÓN EN UPC-UTIM

Hemodinámico-Cardiológico: inicialmente y en relación a shock séptico requirió soporte hemodinámico con noradrenalina con posterior titulación a la baja hasta suspensión.

Durante estadía en UPC presentó episodio de fibrilación auricular rápida, en miras de lograr control de frecuencia inició bisoprolol en dosis creciente y amiodarona de forma intermitente, constatando bradicardia en relación a infusión de esta última.

Fecha Epicrisis : 02/03/2023 02:21

Página 1 de 3

Fecha Última Actualización: 02-03-2023 2:21:37

Página 2 de 3

Se realizó Holter, mostró oscilación de FC entre 48-170. Evaluado por cardiología, se desestimó instalación de MP

Respiratorio: ingresa por insuficiencia respiratoria catastrófica en contexto de neumonía aspirativa con weaning frustrado (21-12), TQT percutánea 28/12, destetando VM 15/01.

Desde el 12/02 nuevamente con requerimientos de VM por atelectasia, congestión, obstrucción e infecciones (traqueobronquitis bacteriana y COVID19).

Se mantuvo en plan de eventual destete tolerando parcialmente ventanas de +/- 30 min. Dada evolución de hoy con progresión de disnea, hipotensión y fiebre se privilegiaron medidas de confort. Se mantiene en plan de destete de VMi por TQT y mantener sedoanalgesia + kinesioterapia

Infeccioso: múltiples intercurrentes infecciosas:

- Neumonía Aspirativa tratada por 10 días con AMS
- Bacteremia por S. hominis tratada por 14 días con Vancomicina y luego rotado a Linezolid por respuesta regular.
- NAVM por E cloacae y E coli MS + ITS CVC por PSAE MS tratada con meropenem
- Infección por COVID19, PCR (+) 08/02
- ITU por E coli tratada
- Traqueobronquitis por PSAE MS y SAMR, tratada con ceftazidima y vancomicina
- Traqueobronquitis por Ps aeruginosa (CAET 27-02), recibiendo ceftazidima

Neurológico: Ingresó por ACV isquémico ACI y M1 izquierda, NIHSS 21 fuera de ventana tratada con trombectomía mecánica 15/12, con control de TAC a las 24 hr sin lesiones, vasos permeables. Neurología indicó suspender aspirina y manejar con anticoagulación con Dalteparina.

En plan de traslape a DACO dado fracaso de TACO (al ingreso en rango y con evento embólico).

Maxilofacial: Evolucionó con clínica de luxación de ATM, realizándose reducción por MXF el 05/01, con indicación de mantener vendaje. posterior a su ingreso a UTIM se determina retiro de vendaje con buena evolución y sin problemas. Sin cambios en esta área.

Dermatológico: El 07/01 destaca al examen físico múltiples lesiones vesiculares destechadas sobre base eritematoso violáceo, en dermatos T1 Y T2, sin compromiso de otras áreas, compatible con herpes zoster (evaluado por dermatología). Se maneja con Aciclovir oral (800 mg cada 4 hrs por 5 v al día) completando 7 días de tratamiento. Sin cambios en esta área.

Gastroenterológico durante la hospitalización se constató alteración de las pruebas hepáticas con trastornos transitorios de las transaminasas y posterior manifestación colestásica. Deberá estudiarse en un segundo tiempo, no es descartable una etiología farmacológica, pero la evolución sugiere la posibilidad biliar.

Actualmente con pruebas hepáticas en descenso, en plan de seguimiento.

Nutricional: Desnutrición moderada. Cursó con distensión abdominal y residuo gástrico aumentado. El 10/02 se suspende NE, queda SNG a caída libre. Actualmente con nutrición enteral reiniciada, en aumento progresivo con regular tolerancia por diarrea (toxina CD negativa) y dolor abdominal. TAC tórax 08/02 muestra distensión esofágica. Chagas (-). Impresiona no tolerar el ENBRACE, se cambia a fórmula estándar.

Rehabilitación:

- Delirium: Modafinilo suspendido por hiperactividad. Por sobresedación se suspendieron sedantes y metadona. Ahora nuevamente inactiva que impresiona en relación a descompensación respiratoria. Una vez optimizado evaluar reinicio de Modafinilo.
- Motor: poco conectada no se ha logrado progresar en los últimos días.
- TQT/ORL/FNA: Evaluada por ORL, se realizó NFC, descrita como normal, por lo que se debe mantener la rehabilitación. Conversado con FNA impresiona con bajo potencial de rehabilitación a corto plazo por lo que tiene agendada GTT (Hoy acude pero es rechazada por necesidad de VMNI en forma permanente, se decide mantener con SNG y evaluar una vez estabilizada) Evaluada por equipo de cuidados paliativos 28-02, impresionó mayor beneficio de medidas de confort y diuréticos por edema. Actualmente con mala perfusión e hipotensión, impresiona mal momento para terapia depleitiva

Fecha Epicrisis : 02/03/2023 02:21

Página 2 de 3

Fecha Última Actualización: 02-03-2023 2:21:37

Página 3 de 3

Durante la tarde se favoreció el acompañamiento familiar logrando la visita de múltiples familiares. Me reuno con hijos, nietos y parejas de estos y se explica pronóstico ominoso y se acuerda privilegiar medidas de confort mientras no prolonguen una agonia.

Se constata fallecimiento a las 01:26. Se avisa a familia

Diagnósticos

- Sd febril - traqueobronquitis por Ps aeruginosa
- ACV isquémico ACM derecha
- Trombectomía mecánica 15/12
- Insuficiencia respiratoria aguda
 - Traqueobronquitis MRSA - PSAE
 - Infección por COVID-19 (PCR (+) del 08/02)
 - TQT percutánea 28/12
 - Paciente crítico crónico: miopatía del paciente crítico, Trastorno deglutorio, Delirium mixto
- Sd. taquicardia bradicardia / FA RVR + FA bloqueada
- ITU E. coli R tazonom, ampicilina/sulbactam, cotrimoxazol
- Previos: Neumonía aspirativa, bacteriemia por S. hominis, NAVM E. cloacae, E. coli, ITS CVC PSAE MS, herpes zoster T1-T2, luxación de ATM.
- Antecedentes: HTA, DM2 NIR, FA en TACO

Diagnóstico de Egreso

- Sd febril - traqueobronquitis por Ps aeruginosa -
- Insuficiencia respiratoria -
- ACV isquémico ACM derecha -

Condición de Egreso Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

Se constata fallecimiento a las 01:26. Se avisa a familia

Plan Post Alta

Se constata fallecimiento a las 01:26. Se avisa a familia

Indicaciones

Tipo de Reposo :

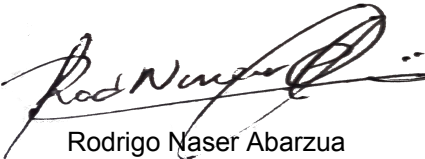
Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente



Rodrigo Naser Abarzua
Médico Tratante (Staff)

Fecha Epicrisis : 02/03/2023 02:21

Página 3 de 3

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 17:38

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar